

Celulitis necrotizante (Fascitis necrotizante)

1. Introducción y relevancia clínica

La celulitis necrotizante es una infección rápidamente progresiva de tejidos blandos que compromete fascia superficial y subcutáneo, con potencial extensión al músculo. Su característica clínica más útil es el **dolor desproporcionado al examen** y la rápida progresión a necrosis cutánea con bullas hemorrágicas. El retraso en su reconocimiento aumenta la mortalidad; por eso, en el EUNACOM y en la práctica clínica, se evalúa la capacidad de **sospechar, iniciar antibióticos y activar cirugía** de forma oportuna. En la semiología dermatológica de preparación para EUNACOM se enfatiza que la fascitis necrotizante puede tornarse “negra”, presentar **vesículas hemorrágicas** y requiere **debridación quirúrgica más antibióticos (penicilina/cloxacilina + clindamicina)**, lo que refleja el estándar de manejo en la urgencia.

En el box de urgencia, el principal error es tratarla como una celulitis o erisipela no complicada. Ante **fiebre alta, dolor intenso, placas violáceas o negruzcas y bullas** se debe asumir fascitis hasta demostrar lo contrario y **derivar precozmente a pabellón**. Los apuntes clínicos utilizados para EUNACOM recomiendan confirmar con imagen si persiste la duda con erisipela/celulitis, privilegiando **ecografía o resonancia**; lo clave es **no demorar la cirugía** si la sospecha es alta.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La fascitis necrotizante se clasifica, de forma práctica, en:

- **Tipo I (polimicrobiana):** mezcla de bacilos Gram negativos, cocos Gram positivos y anaerobios; frecuente en diabéticos, inmunosuprimidos, úlceras o heridas perineales. Produce gas en tejidos y puede asociarse a sepsis grave.
- **Tipo II (monomicrobiana):** típicamente *Streptococcus pyogenes* (estreptococo β -hemolítico del grupo A); explica muchos cuadros de inicio brusco en piel aparentemente sana. En este contexto, la **clindamicina** es fundamental porque **inhibe la síntesis de toxinas** (efecto antitoxina) y actúa en fase estacionaria, potenciando a la penicilina. En materiales docentes de EUNACOM se señala tratamiento con **penicilina EV + clindamicina** y la **debridación quirúrgica** como pilar.

La activación sistémica por **superantígenos** (estrepto/estafilo) puede gatillar **shock tóxico**, cuadro vasodilatador de alta letalidad que exige reanimación con cristaloides y drogas vasoactivas, además de antibióticos dirigidos a estos patógenos y **clindamicina** por su

acción antitoxina. El material de estudio resume: “shock tóxico... vasodilatador (no responde solo a volumen)... letalidad alta... manejo con penicilina o cloxacilina + clindamicina EV + drogas vasoactivas”.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

Presentación clínica típica

- **Dolor intenso, desproporcionado** a los hallazgos cutáneos iniciales.
- Rápida progresión (horas) a **eritema/placa violácea, edema tenso, hipoestesia** (por trombosis de vasos cutáneos y necrosis neurológica superficial).
- **Bullas hemorrágicas** y áreas **negruzcas** de necrosis superficial en evolución.
- Síndrome tóxico: fiebre alta, taquicardia, hipotensión; eventual **shock tóxico** por estrepto/estafilo.

Diagnóstico diferencial

- **Erisipela** (*S. pyogenes*): placa eritematosa con **bordes nítidos**, fiebre y compromiso linfático. Cuando hay **dolor extremo** y/o **bulas hemorrágicas**, sospechar fascitis; si hay duda, confirmar con **RNM o ecografía**.
- **Celulitis** (*S. aureus/S. pyogenes*): placa eritematosa de **bordes difusos** con dolor y fiebre; se maneja EV con **cloxacilina/cefazolina**. Si aparece dolor desproporcionado o progresión acelerada, reevaluar como fascitis.
- **Gangrena gaseosa (mionecrosis clostridial)**: dolor severo, crepitación, gas subcutáneo, progresión fulminante; cirugía inmediata + cobertura para anaerobios.
- **Trombosis venosa, síndrome compartimental, piomiositis, pioderma gangrenoso** (este último no infeccioso; **evitar desbridar** si el cuadro es compatible).

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico es **clínico** y la **confirmación es quirúrgica** (exploración y debridación). No debe retrasarse la cirugía por exámenes.

Exámenes útiles (sin demorar):

- **Laboratorio**: hemograma, PCR, lactato, electrolitos, función renal/hepática, coagulograma, gases, hemocultivos (antes de antibióticos si es posible).

- **Imágenes (si la duda es razonable y hay disponibilidad inmediata):**
 - **Ecografía** de tejidos blandos: líquido fascial, gas subcutáneo; puede ayudar en la cama del paciente.
 - **Resonancia magnética:** muy sensible para engrosamiento fascial, realce y líquido en planos; sugerida cuando se duda entre erisipela/celulitis vs. fascitis y **no retrasa** la cirugía. Las notas EUNACOM aconsejan **eco o RNM** para confirmar si persiste duda con erisipela.

Perla práctica: si hay **dolor extremo, progresión en horas, bullas hemorrágicas y signos de toxicidad sistémica, avanza a pabellón** con antibióticos de amplio espectro. Las imágenes son complementarias; el **tiempo quirúrgico** salva vidas.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

Los pilares son **reanimación, antibióticos de amplio espectro con clindamicina, y debridación quirúrgica urgente** (repetida si es necesario). El material docente nacional y de preparación EUNACOM enfatiza combinaciones como **penicilina EV + clindamicina** (para estreptococo) y, en escenarios polimicrobianos o graves, **esquemas ampliados**; además, **debridación** sin demora.

A. Medidas iniciales en Urgencia

1. **ABC, dos vías venosas**, monitor, oxígeno.
2. **Cristaloides** (p. ej., solución salina balanceada) titulados a PAM ≥ 65 mmHg; si persiste hipotensión, **drogas vasoactivas** (norepinefrina) como en shock vasodilatador.
3. **Hemocultivos** (si posible sin retraso), laboratorios base y lactato.
4. **Antibióticos EV precoces** (no esperar imágenes).
5. **Cirugía:** evaluar y **pasar a pabellón** para exploración y desbridación amplio.

B. Antibióticos empíricos (iniciar de inmediato)

- **Cobertura para estreptococo + antitoxina: penicilina EV + clindamicina EV.**
- **Si sospecha polimicrobiana/anaerobios** (diabetes, periné, úlcera crónica, postoperatorio): añadir **cobertura Gram negativa y anaerobia**. En contextos hospitalarios chilenos se utilizan β -lactámicos de amplio espectro (p. ej., **piperacilina/tazobactam, o carbapenémico**); en materiales locales se menciona **ertapenem** como alternativa con buen rendimiento en infecciones graves de tejidos

blandos en hospitalizados. Ajustar según cultivo.

Nota sobre **shock tóxico**: si existe, cubra estafilococo/estreptococo (p. ej., **cloxacilina o penicilina EV + clindamicina**) y maneje como shock vasodilatador (cristaloides + vasopresor).

C. Cirugía

- **Desbridación urgente**: remover tejido necrótico hasta margen vital; puede requerir **reintervenciones seriadas** cada 24–48 h.
- **Drenaje de colecciones**, lavado abundante. En los resúmenes de cirugía para EUNACOM se refuerza la importancia de **aseo quirúrgico** cuando hay infección profunda con necrosis.

D. Soporte y cuidados adicionales

- **Analgesia** efectiva.
- **Profilaxis antitetánica** si procede.
- **Nutrición**: considerar requerimientos elevados en catabolismo séptico.
- **Cuidado de heridas** y planificación de **cobertura cutánea** (injertos) cuando el lecho esté limpio.

6. Complicaciones y pronóstico

- **Sepsis y shock séptico/ tóxico**: evolución veloz con hipotensión refractaria; los materiales docentes insisten en su **alta letalidad** y en el uso de **clindamicina** por efecto antitoxina.
- **Falla multiorgánica**, coagulación intravascular diseminada.
- **Pérdida masiva de tejido**, necesidad de múltiples debridaciones, injertos o colgajos.
- **Amputación** en extremidades.
- **Secuelas funcionales** y estéticas.

El **pronóstico** depende del **tiempo a cirugía** (factor más modificable), extensión, comorbilidades (diabetes, inmunosupresión) y foco (periné, abdomen, extremidades). El

inicio temprano de antibióticos + clindamicina y el desbridamiento agresivo mejoran la supervivencia.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas

- **Dolor fuera de proporción + bullas hemorrágicas = pensar fascitis;** inicie **ATB EV + clindamicina** y llame a cirugía.
- Si la “celulitis” **progresas en horas** o aparece **hipoestesia**, re-clasifique como fascitis.
- En erisipela con **demasiado dolor** o **bulas hemorrágicas**, utilice **eco/RNM** si la duda persiste **sin retrasar** la decisión quirúrgica.
- **Clindamicina** siempre que sospeche estreptococo o shock tóxico (antitoxina).
- En cuadros hospitalarios severos o con foco polimicrobiano, considere **β -lactámico de amplio espectro/carbapenémico**; el material clínico local comenta **ertapenem** como alternativa válida en infecciones graves internadas.

Errores frecuentes

- **Esperar imágenes** para decidir cirugía. La confirmación es **quirúrgica**; la imagen **no puede** retrasar el desbridamiento cuando la sospecha es alta.
- **Tratar como celulitis simple** (solo cloxacilina) un cuadro con **dolor desproporcionado** y progresión acelerada.
- Olvidar **clindamicina** (antitoxina) en sospecha de estreptococo/shock tóxico.
- No **reexplorar**: muchas veces requiere **debridaciones seriadas**.
- Subestimar la necesidad de **UCI** en pacientes con inestabilidad hemodinámica y reanimación avanzada.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Sospeche temprano:** dolor desproporcionado, **progresión rápida**, **bulas hemorrágicas** y zonas necróticas hacen diagnóstico clínico de fascitis hasta demostrar lo contrario.

2. **No demore la cirugía:** la confirmación es quirúrgica. Las imágenes (eco/RNM) **solo si no retrasan** el debridamiento.
3. **Antibióticos EV inmediatos: penicilina/cloxacilina + clindamicina** por efecto antitoxina; amplíe espectro si foco polimicrobiano grave (p. ej., **carbapenémico** en hospitalizados).
4. **Reanimación como en shock séptico/vasodilatador:** cristaloides, vasopresor si requiere, UCI en inestables.
5. **Shock tóxico** por estrepto/estafilo es letal: mantenga **clindamicina** y cobertura adecuada, más soporte hemodinámico.
6. **Reintervenciones** son frecuentes: debridaciones seriadas hasta lecho vital limpio.
7. **Evite el error** de tratar como celulitis/erisipela una fascitis; **el tiempo a pabellón salva vidas.**